# EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 75870
SERVICIO : UTI HSC
FECHA : 2023-12-16 11:45:00

## DATOS DEL PACIENTE:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | : BENICIO JOSE ARZOLA MEDINA | | | RUN | : 2.828.759-3 |
| F.Nac | : 30-08-1934 | Edad | : 89 AÑOS, 3 MESES | Género | : Masculino |
| Dirección | : DIAGONAL NAVOTAVO 220 | | | Comuna | : SAN CARLOS |
| Previsión | : FONASA B | Teléfono | : 993966799 | | |
| Fecha Ingreso | : 2023-12-13 | Fecha Egreso | : 2023-12-16 11:45:00 | Causal | : MEDICA |
| Condición | : VIVO | Destino | : HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA | Derivación | : |

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R05.X-TOS

## DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Neumonía basal izquierda
2. ITU por Klebsiella Pneumoniae BLEE
3. Antecedentes: HTA, ICC, Cardiopatía coronaria, FA Persistente en TACO, Enfermedad Arterial Periférica Fontaine III , Amputación Supracondílea Izquierda.

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. J18.0-BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. I50-INSUFICIENCIA CARDIACA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. I48-FIBRILACION Y ALETEO AURICULAR (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

## COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes de HTA, ICC, cardiopatía coronaria y amputación supracondílea izquierda; consulta en SU HSC el día 13.12.23 por cuadro caracterizado por compromiso del estado general, tos productiva, disnea, episodios febriles asociado a orinas oscuras y de mal olor. Paciente se habría automedicado con amoxicilina en domicilio. Se solicitan exámenes donde estaca EOC inflamatoria, PCR 81, GB 20700, función renal conservada.. Rx tórax con infiltrado intersticial bilateral mayor a izquierda. Se solicita evaluación por médico UTI y se decide ingreso a unidad para continuar tratamiento médico. Paciente ingresa a UTI en regulares condiciones generales, afebril, hemodinamicamente estable, apoyado con naricera 2 litros, sin UMA.
Evolución UTI:
- Sin compromiso hemodinámico durante estadía en UTI. Mantiene tratamiento antihipertensivo y se ajusta tto. de Insuficiencia cardiaca por cardiología. Recibiendo Xarelto por antecedente de FA.
- En lo ventilatorio, requiere inicialmente apoyo FiO2 por naricera hasta 2 lt, con rápido destete antes de 24 hrs desde su ingreso. Recibe apoyo broncodilatador y kinésico, con escasa signología obstructiva.
- En lo infeccioso, ingresa con parámetros inflamatorios aumentados, con orina completa inflamatoria, afebril, por lo que se toma Urocultivo, prácticamente sin secreción bronquial por lo que no se logra tomar CSB, antígeno covid negativo. Se inicia cobertura empírica con ceftriaxona, ajustándose el 15/12 a Meropenem tras resultado (+) UC Klebsiella BLEE. Se decide cambiar a ertapenem para continuar tratamiento en domicilio.
- Presenta episodio de desorientación nocturna manejada con quetiapina, con buena respuesta. Actualmente orientado temporo-espacialmente y tranquilo.
- Sin conflicto renal ni metabólico durante su hospitalización.

En vista de buena evolución clínica, se decide continuar tratamiento antibiótico por HODOM.

## PLAN DE MANEJO:

Completar tratamiento antibiótico por HODOM
Control CAE cardiología según control habitual

## INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido
2. Regimen común
3. Ertapenem 1 g al día ev (1/7)
4. Xarelto 20 mg/día vo
5. Omeprazol 20 mg 1 capsula antes del desayuno vo
6. Pregabalina 75 mg noche vo
7. Cilostazol 100 mg 1 comp c/12 hrs vo
8. Atorvastatina 40mg 1 cada 24hs vo
9. Espironolactona 25 mg/día vo
10. Hidroclorotiazida 50 mg 1/4 comprimido al día vo
11. Bisoprolol 2.5 mg 1 y 1/2 comprimido al dia vo
12. Bromuro ipratropio 4 puff c/6hrs c/AC
13. Sertralina 50mg 1comprimido en la mañana vo
14. Quetiapina 25 mg 1comprimido en la noche vo
15. Control en Policlínico de cardiología según citación habitual
16. HODOM: completar tratamiento antibiótico con ertapenem / control función renal, ELP, hemograma y PCR próximo miércoles 20/12

## EXÁMENES Y RESULTADOS

15/12: crea 0.8 PCR 140 ELP 138/4.3/109 Gb 20200 Hb 12.3PLT 201 mil GSA: pH 7.44 pCO2 29 pO2 107 FiO2 21%
14/12:crea 0.9 ELP normales PCR 162
13/12/23: UC + KLEBSIELLA P. BLEE

Ana Sepúlveda Venegas
MEDICO TRATANTE
13383078-2

JEFE SERVICIO